VästKom

Inriktningsdokument för kommunernas primärvårdsuppdrag i Västra Götaland

REMISSVERSION

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5073, 402 22 GÖTEBORG
E-post: info@vastkom.se
Org.nr: 858501–2084

Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG
www.vastkom.se

VästKom

Innehållsförteckning

Inledning 3

Syfte 3

Målgrupp 3

Läsanvisning 3

Giltighet 3

Kommunens lagreglerade och avtalade ansvarsområden inom primärvård 4

Kommunal primärvård 4

Kompetens 5

Patientsäkerhet 5

Beslut om kommunal primärvård 5

Ansvar 5

Initiering 5

Bedömning och beslut 6

Information om beslut 6

Vistelse i annan kommun 7

Beslut om egenvård 7

Hälso- och sjukvård i hemmet 7

Vårdnivåer 7

Samverkan 8

Team och fast vårdkontakt 9

Uppföljning 9

Styrande dokument 10

REMISSVERSION

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5073, 402 22 GÖTEBORG
E-post: info@vastkom.se
Org.nr: 858501–2084

Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG
www.vastkom.se

Inledning

Inriktningsdokument för kommunernas primärvårdsuppdrag i Västra Götaland (fortsättningsvis kallat dokumentet), är framtaget för att tydliggöra den gemensamma syn som länets 49 kommuner har på kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå.

Dokumentet har ett kommunalt perspektiv och utgår från gällande lagstiftning, hälso- och sjukvårdsavtal samt tillhörande överenskommelser.

Dokumentet är framtaget på uppdrag av VästKoms styrelse för att skapa en samsyn kring det kommunala primärvårdsuppdraget i Västra Götalands 49 kommuner.

Syfte

Syftet är att konkretisera och förtydliga kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar på primärvårdsnivå, som stöd för enhetlig tillämpning av hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser.

Målgrupp

Dokumentet riktar sig till tjänstepersoner med ansvar för kommunens primärvård.

Läsanvisning

Dokumentet ska läsas tillsammans med gällande lagstiftning och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Dispositionen är utformad för att stegvis beskriva den gemensamma ramen för kommunernas primärvårdsuppdrag. Först beskrivs uppdraget, därefter ansvar, beslut och hur uppdraget ska tillämpas. Avslutningsvis behandlas samverkan, teamarbete och uppföljning. Alla avsnitt hänger ihop och ska läsas som en helhet.

Giltighet

Detta dokument börjar gälla den 1 januari 2028 under förutsättning att samtliga kommuner i Västra Götaland ställer sig bakom dokumentet.

Dokumentet utgår från det hälso- och sjukvårdsavtal som träder i kraft den 1 januari 2027. Dokumentet ska därför ses över senast i samband med att hälso- och sjukvårdsavtalet löper ut, ersätts eller förändras på ett sätt som påverkar det kommunala primärvårdsuppdraget. Revidering kan även göras om en eller flera kommuner ser behov av det.

Behov av revidering eller besked om att en kommun inte längre står bakom dokumentet lämnas skriftligt till VästKom. Om en kommun upphäver sitt beslut att stå bakom dokumentet, upphör dokumentet att vara länsgemensamt för samtliga kommuner sex månader efter att beskedet inkommit till VästKom. Under denna period informeras övriga kommuner och fortsatt hantering eller revidering kan påbörjas.

REMISSVERSION

Kommunens lagreglerade och avtalade ansvarsområden inom primärvård

Kommunen ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) för att erbjuda en god hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå till personer som bor i eller vistas vid:

- Särskilt boende för äldre
- Korttidsplats
- Dagverksamhet
- Bostad med särskild service
- Daglig verksamhet

Samtliga ovan nämnda insatser förutsätter beslut enligt socialtjänstlagen (2025:400), SoL, eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Utöver det lagstyrda ansvaret kan kommunen, genom överenskommelse med regionen, ansvara för hälso- och sjukvård i ordinärt boende. I Västra Götalands län har kommunerna och Västra Götalandsregionen, fortsättningsvis regionen, kommit överens om att kommunen ansvarar för sådan vård. Ansvarsfördelning mellan regionen och kommunen regleras i regleras i hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

Kommunal primärvård

Kommunernas hälso- och sjukvård bedrivs på primärvårdsnivå och omfattar personer i alla åldrar. Den kommunala primärvården omfattar även rehabilitering och habiliteringsinsatser. Kommunerna i Västra Götaland ansvarar också för att förse patienter inom kommunens ansvarsområde med hjälpmedel. Förskrivar- och kostnadsansvar regleras i särskilda avtal och överenskommelser mellan kommunerna och regionen.

Primärvårdens grunduppdrag enligt Hälso- och sjukvårdslagen, innebär att inom ramen för sin verksamhet;

- tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov,
- se till att vården är lätt tillgänglig,
- tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar,
- tillhandahålla rehabiliterande insatser utifrån patientens individuella behov och förutsättningar,
- samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården, och
- möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.

I detta dokument avses med vanligt förekommande vårdbehov sådana hälso- och sjukvårdsinsatser som regelbundet uppstår i befolkningen och som utifrån förekomst och komplexitet kan förväntas hanteras på primärvårdsnivå och inom ramen för sedvanlig verksamhetsplanering.

REMISSVERSION

Kompetens

Utifrån kommunernas grunduppdrag och ansvar för primärvård i länet utgörs den kommunala primärvården av legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Den kommunala primärvården har möjlighet att utvidga sin verksamhet genom att tillhandahålla specialistutbildad personal och andra yrkeskategorier, till exempel dietist och farmaceut, vilket då är att betrakta som en utökning av kommunens grunduppdrag.

Kommunens tillgång till läkare regleras i Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelse om läkaransvaret inom kommunal primärvård. Tillgång till läkare beskrivs i den gemensamma närområdesplanen (GNOP).[1] Det finns även möjlighet utifrån hälso- och sjukvårdslagen för en kommun att anställa läkare. Detta är ett åtagande utöver grunduppdraget och beslutas av enskild kommun.

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en grundläggande del av den kommunala primärvården. Den bygger på ett systematiskt och förebyggande arbete som aktivt bidrar till att minska risker och främja en trygg och säker vård. Enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet ska kommun och region samverka och arbeta systematiskt och förbättra patientsäkerheten för den gemensamma patienten.

För att vården ska kunna genomföras säkert krävs både bedömningar i varje enskild situation och organisatoriska förutsättningar i verksamheten. Ansvaret för patientsäkerheten finns därav på flera nivåer i organisationen, genom ledning, organisering, kompetens, rutiner och uppföljning. Kommunens systematiska patientsäkerhetsarbete beskrivs årligen i patientsäkerhetsberättelsen. Verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har utifrån sina respektive roller och ansvarsområden ett särskilt ansvar för patientsäkerhet inom kommunal primärvård.

Patientsäkerheten vid insatser i kommunal primärvård påverkas av patientens behov och förutsättningar samt av boendemiljö, situationen i hemmet och andra omständigheter som har betydelse för hur insatsen kan genomföras. Det innebär att varje insats behöver bedömas individuellt utifrån patientens situation och förutsättningarna för ett säkert genomförande.

Beslut om kommunal primärvård

Ansvar

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå när det, enligt gällande lagstiftning och hälso- och sjukvårdsavtalet, har bedömts att patienten omfattas av kommunens ansvar. Det är den ansvariga kommunen som utifrån denna bedömning avgör om patienten ska få kommunal primärvård.

Initiering

Behov av kommunal primärvård kan uppmärksammas av patienten själv, närstående, kommunen eller regionen. Kommunen tar emot förfrågan och bedömer behovet av kommunal primärvård. Om patienten har

[1] GNOP beskriver den lokala samverkan mellan kommun och region, bland annat avseende läkaransvar, kontaktvägar, planering och uppföljning.

behov av insatser från både region och kommun ska en samordnad individuell plan (SIP) erbjudas i syfte att tydliggöra ansvar, planering och uppföljning.[2]

Bedömning och beslut

Kommunal primärvård kan bli aktuell när patienten, på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning, inte utan betydande svårighet kan ta sig till regionens mottagningar, varken självständigt eller med stöd såsom färdtjänst eller sjukresa.

Bedömningen ska särskilt beakta om behovet är varaktigt eller återkommande samt om insatserna behöver ges regelbundet i hemmet. I enlighet med grundprincipen i hälso- och sjukvårdsavtalet bör behov som redan från början bedöms som långvariga och/eller frekventa hanteras inom kommunal primärvård. En samlad bedömning görs utifrån behovets varaktighet, frekvens samt vad som bäst tillgodoser patientens trygghet och kontinuitet.

Det är kommunens legitimerade sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut som gör bedömning av behov av och beslutar om kommunal primärvård är aktuellt. Kommunen kan ha ett särskilt vårdplaneringsteam som ansvarar för bedömningen. I komplexa ärenden kan andra ledande funktioner, exempelvis verksamhetschef, MAS och MAR, medverka i bedömningen.

En förutsättning för bedömning är att kommunens legitimerade personal har tillgång till relevant och aktuell information om patientens hälsotillstånd, funktion, aktivitetsförmåga, risker, pågående och planerade åtgärder samt en aktuell läkemedelslista.

För beslut om kommunal primärvård krävs att patienten har en namngiven fast läkarkontakt samt att nödvändig kompetens finns inom kommunen för att utföra aktuella insatser. Beslut om kommunal primärvård ska föregås av en planering som tydliggör vilka insatser kommunen ansvarar för, vilket ansvar regionen eller annan behandlande vårdgivare har, samt hur samordning och uppföljning ska ske. Beslutet ska även grundas på en samlad bedömning av patientens behov, risker och förutsättningar för en säker vård i hemmet.

Information om beslut

Kommunen ansvarar för att informera patienten och, när det är relevant, närstående om beslut om kommunal primärvård samt om eventuella avgifter. Om kommunen bedömer att kommunal primärvård inte ska erbjudas och kontakt inte har upprättats med patient eller närstående, ansvarar regionen för att meddela detta.

Kommunens legitimerade personal bedömer när patienten inte längre har behov av insatser från kommunal primärvård. Kommunen ansvarar för att informera patienten och vid behov närstående om beslutet. I samband med att insatserna avslutas sker nödvändigt informationsutbyte med regionen.

[2] Samordnad individuell plan, SIP, regleras i gällande lagstiftning och beskrivs närmare i länsgemensam riktlinje för samordnad individuell plan, SIP.

Vistelse i annan kommun

Vid vistelse i annan kommun ska ansvarsfördelningen klargöras utifrån patientens aktuella behov.[3] Ett tidigare beslut om kommunal primärvård i annan kommun innebär inte att insatser automatiskt fortsätter oförändrat. Vid behov av samordning mellan flera aktörer kan SIP erbjudas.

Beslut om egenvård

I enlighet med gällande lagstiftning kan kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal, inom sitt uppdrag, bedöma och fatta beslut om egenvård.[4] Egenvård utförs av patienten själv, närstående eller med stöd av personal inom kommunens socialtjänst eller verksamheter enligt LSS.

Bedömning av egenvård ska göras individuellt av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i samråd med patienten och utgå från patientens behov, resurser och livssituation. Planeringen ska om möjligt ske i tillsammans med patienten, så att egenvården genomförs på ett tryggt och patientsäkert sätt.

När egenvården kräver stöd från andra ansvarar den som gör bedömningen för planering och samordning av insatserna tillsammans med patienten eller den som ska utföra egenvården. Samråd kan även behöva ske tillsammans med verksamhetsansvariga.

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som fattar beslut om egenvård ansvarar för uppföljning och ska ompröva beslutet vid förändrade förutsättningar. I beslutet ska det framgå hur återkoppling sker vid förändringar i patientens tillstånd. Uppföljningsansvaret kan inte överlåtas till annan vårdgivare utan att behandlingsansvaret samtidigt tas över. Vid behov av samordning ska en samordnad individuell plan (SIP) upprättas enligt gällande riktlinje.

Hälso- och sjukvård i hemmet

Med hemmet avses den plats där patienten är stadigvarande bosatt eller vistas och där kommunal primärvård ges inom ramen för kommunens ansvar enligt gällande lagstiftning och avtal. Begreppet omfattar ordinärt boende, särskilt boende för äldre, bostad med särskild service enligt LSS samt andra boendeformer som kommunen ansvarar för.

Hälso- och sjukvård i hemmet kan utföras av kommunal primärvård, regional primärvård och av regionens specialiserade vård. I Västra Götalands hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser regleras huvudmännens ansvarsområden.

Vårdnivåer

Hälso- och sjukvårdens nivåstruktur kan sammanfattas som primärvård (kommunal och regional), specialiserad vård och högspecialiserad vård. Primärvård utgör den första vårdnivån och omfattar medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete, habilitering och rehabilitering. Specialiserad vård är vård som kräver särskild medicinsk kompetens eller medicinska resurser som inte ryms inom primärvårdens uppdrag. Högspecialiserad vård avser vård som är särskilt komplex eller sällan förekommande och som kräver viss volym, multidisciplinär kompetens eller särskild utrustning.

[3] Ekonomisk ersättning mellan kommuner vid vistelse i annan kommun regleras i särskild länsgemensam överenskommelse om ersättningsbelopp i Västra Götaland.
[4] Egenvård regleras i gällande lagstiftning och beskrivs närmare i länsgemensam riktlinje för egenvård.



Bild: Förenklad beskrivning av vårdnivåer inom Svensk Hälso- och sjukvård. Källa: bilden är framtagen med stöd av AI.

Gränsen mellan primärvård och specialiserad vård är inte statisk utan beror på om det krävs särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens. Denna gräns förändras i takt med medicinsk och teknisk utveckling. Krävs särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens är insatsen att betrakta som specialistvård och ett ansvar för regionen. Utförandet kan då inte utan vidare överföras till primärvårdsnivå. Vid bedömning av vårdnivå ska utgångspunkten vara om insatsen ryms inom primärvårdens uppdrag och kan utföras patientsäkert med de resurser och den kompetens som krävs. Nya insatser och arbetssätt behöver införas genom en strukturerad process som beaktar ansvar, kompetens, resurser och patientsäkerhet.

Det är skillnad på ordinations- och utförarnivå. Utförandet av en insats kan vara på primärvårdsnivå även om ordinationen kommer från den specialiserade vården. Bedömningen av vårdnivå utgår från vilken kompetens och vilka resurser som krävs för utförandet, inte från ordinatörens organisatoriska tillhörighet. För insatser som kan utföras på primärvårdsnivå kan utförandet ske inom såväl regional som kommunal primärvård, även när patienten samtidigt har pågående specialiserad vård i hemmet.

Kommunal primärvård kan medverka i, och delvis utföra, hälso- och sjukvård som den specialiserade vården ansvarar för. Detta förutsätter att:

- berörda verksamheter gemensamt har bedömt att åtgärderna kan genomföras på ett patientsäkert sätt inom primärvården
- berörda verksamheter har fört dialog och enats om förutsättningarna
- det finns en fast läkarkontakt och fast vårdkontakt på primärvårdsnivå
- insatserna inte kräver någon särskild organisation

Patientens trygghet och säkerhet ska alltid komma först, och åtgärderna ska utföras av personal med rätt kompetens. Kommunen ska som stöd i bedömningen beakta:

- om det är lämpligt att åtgärderna utförs i hemmet
- vilka risker som finns med att utföra åtgärderna i hemmet
- om personalen kan få stöd och utbildning för att utföra åtgärderna på ett tryggt och enhetligt sätt

Samverkan

Samverkan är en grundförutsättning för kommunal primärvård. Kommunen är beroende av en väl fungerande samverkan både internt, till exempel mellan kommunal primärvård och socialtjänst, och externt med regionen och andra berörda aktörer. Detta är särskilt viktigt när ansvaret delas mellan eller flyttas från en vårdgivare till

en annan, så att patientens vård fortsätter utan avbrott eller oklarheter. Samverkan behöver utformas utifrån kommunens lokala förutsättningar, till exempel organisation och involvering av privata aktörer. Den gemensamma närområdesplanen, GNOP, är ett stöd för att konkretisera hur samverkan mellan kommun och region ska fungera lokalt, bland annat när det gäller ansvarsfördelning, kontaktvägar, läkarstöd och uppföljning.

När en patients behov kräver särskild kompetens eller teknisk utrustning behöver kommunen och regionen samverka för att vården ska kunna planeras och genomföras på ett patientsäkert sätt. Kommunen ansvarar för att identifiera och kommunicera behov av kompetenshöjande insatser, stöd och eventuella patientsäkerhetsrisker. Regionen ansvarar för att ge relevant handledning, information, kompetensöverföring och stöd vid enskilda insatser där särskild kompetens eller teknisk utrustning behöver användas. Om nödvändiga förutsättningar saknas behöver insatsen hanteras på annat sätt.

Många patienter med hälso- och sjukvård i hemmet har insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten eller verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det innebär att personal som ger vård och omsorg i hemmet kan växla mellan arbetsuppgifter som omfattas av olika lagar och regler. Detta ställer särskilda krav på samverkan mellan verksamheterna, så att ansvarsfördelning, informationsöverföring och planering är tydlig för alla berörda. Hur samverkan närmare ska utformas framgår av hälso- och sjukvårdsavtalet, tillhörande överenskommelser samt delregionala och lokala överenskommelser, rutiner och riktlinjer.

Team och fast vårdkontakt

Primärvård är den första vårdnivån och förutsätter ett väl fungerande teamarbete för att möta patientens samlade behov. För patienter med kommunal primärvård behöver flera professioner kunna samverka kring patienten. Teamet kan bestå av kommunens legitimerade personal, regionens läkare och, när det är aktuellt, andra berörda inom socialtjänstens verksamheter.

För patienter som omfattas av kommunal primärvård ska kommunen utse en fast vårdkontakt om patienten begär det eller om det inte är uppenbart obehövligt. Den fasta vårdkontakten ska bidra till trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet genom att planera och följa upp patientens kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska fast vårdkontakt utses i regionen.

Regionen tillhandahåller fast läkarkontakt inom ramen för sitt läkaransvar i kommunal primärvård. Den fasta läkarkontakten svarar för läkarkontinuitet i primärvården och ska, för patienter som omfattas av kommunal primärvård, delta i planering, samordning och uppföljning av patientens hälso- och sjukvård samt i upprättandet av individuell plan. När det är aktuellt kan patienten också ha en fast omsorgskontakt inom omsorgen. Patienten ska få information om vem som är patientens fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt samt hur kontakt tas med dem.

Uppföljning

Detta inriktningsdokument ska följas upp med fokus på hur det används och om det bidrar till en tydligare och mer gemensam förståelse av kommunal primärvård i Västra Götalands kommuner. Uppföljningen ska belysa om dokumentets syfte uppnås samt om innehållet är känt i berörda verksamheter.

Varje kommun ansvarar för att dokumentet implementeras och görs känt i verksamheten. Uppföljning bör ske både i kommunen och gemensamt mellan kommuner, för att ge underlag för fortsatt utveckling, revidering och samsyn.

REMISSVERSION

Styrande dokument

Centrala lagar och regelverk för kommunal hälso- och sjukvård

- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) – reglerar ansvar, vårdens mål och kvalitet
- Patientsäkerhetslagen (2010:659) – reglerar patientsäkerhetsarbete och ansvar
- Patientlagen (2014:821) – stärker patientens ställning, delaktighet och rätt till information
- Patientdatalagen (2008:355) – reglerar dokumentation och hantering av patientuppgifter
- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) – reglerar sekretess och informationsöverföring
- Socialtjänstlagen (2025:400) – relevant då insatser ofta ges parallellt med socialt stöd
- Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – reglerar samverkan mellan kommun och region
- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade – relevant då kommunal primärvård ofta ges i verksamheter enligt LSS
- Smittskyddslagen (2004:168) – innehåller bestämmelser om smittskydd och förebyggande av smittspridning
- Lag (2022:1250) om egenvård – definierar egenvård som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att patienten kan utföra själv eller med hjälp av någon annan
- Lag (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation – berör informationsöverföring, samverkan

Avtal, överenskommelser och länsgemensamma styrdokument

- Hälso- och sjukvårdsavtalet – reglerar hälso- och sjukvårdsansvar mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
- Överenskommelse om kommunens betalningsansvar vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
- Överenskommelse om regionens läkaransvar i kommunal primärvård
- Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med skadligt bruk och beroende
- Överenskommelse om samverkan om munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård
- Länsgemensamma riktlinjer, rutiner och andra styrande dokument som reglerar samverkan mellan kommunerna och regionen

Föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd är centrala för kommunal primärvård, exempelvis inom ledningssystem för kvalitet, journalföring, läkemedelshantering, delegering och egenvård.

REMISSVERSION